

NS 22222363027 / 517

LUIZ EUGENIO DAVI

IDADE: 43 PESO: 77 ALTURA: 1.73 PROFISSÃO: Deleg./Aposent. 9a.

SINTOMAS: Perda da memória

QUEIXAS:

MEDICAMENTOS: Benicar / Dioprex / Trezor / Avolexin / Rosuvastatina / Donarem / Prisma

MÉDICO: Drº Pedro Macedo

EXERCÍCIO FÍSICO: 3ª e 5ª funcional

HORARIO DAS REFEIÇÕES - CAFÉ: ALMOÇO: LANCHE: JANTAR:

HORA QUE DORME: 21:45 HORA QUE ACORDA: 6:30 - 7hr

COCHILHO () SIM (X) NÃO DORME ACOMPANHADO () SIM () NÃO () EVENTUAL

BEBIDA ALCOÓLICA () SIM () X NA SEMANA (X) NÃO

FUMO () SIM () MAÇO/DIA (X) NÃO - PAROU A QUANTO TEMPO:

TIPO DE RESPIRAÇÃO: nasal BANHEIRO: 4X

CIRCUNFERÊNCIA ABDOMINAL: III CIRCUNFERÊNCIA PESCOÇO:

OVERLAP: Negativa MALLAMPATI: IAH: 16 e/ev SPO2: 83%

PATOLOGIAS ASSOCIADAS:

CIRURGIAS: (N) NASAL (N) AMIGDALECTOMIA Drº Pedro

HIPOVENTILAÇÃO DA OBESIDADE: não

COMORBIDADE: (S) RESPIRATÓRIA (S) ENDÓCRINA () CARDÍACA

(N) ORTOPÉDICA (N) NEUROLÓGICA () OUTROS

IAH = 16 e/ev - SpO2 = 83%

01/08/23 P = 9 cm H2O
IAH = 6.8

Coloco em Pressão fixa de 9 cm H2O

M. de uso: 9h45'

Bem adaptado, s/ queixas.

10/08/23 P = 9 cm H2O
IAH = 15.3 e/ev
M. de uso: 8hr.

fua Cláudia

15/09/23 P = 10 cm H2O
IAH = 7.3 e/ev
M. de uso: 5h30'
Fuga = 13.9 l/min.

Bem adapt.

fua

04/10/23 P = 10 cm H2O
IAH = 5.4 e/ev
M. de uso: 5h23'

fua

08/12/23 P = 10 cm H2O
IAH = 6.6 e/ev
Fuga = 21.2

Bem adapt.

fua

08/02/24 P = 10 cm H2O
IAH = 5.5 e/ev
M. de uso: 4h47'
Fuga = 1.3 l/min.

Bem adapt. porém ele relata que esqueceu de levar

Parou o Donarem

03/04
24 } m. de uso: 4h50'
IAH = 4.0
P = 10 cm H₂O
Fuga = 12.4 lpm.

Jua.

15/05
24 } P = 10 cm H₂O
IAH = 5.5 elev
m. de uso: 5h40'

Jua

10/07
24 } P = 10 cm H₂O Bem adaptado.
IAH = 4.5 elev
m. de uso: 7hrs.
fuga: 53.4

19/12
24 } P = 10
IAH = 4.5
Barou puxada

26/02
25 } P = 10 cm H₂O Bem adaptado, porém ele
IAH = 8.7 elev mudou de casa
m. de uso: 4h30'
troco e filtro

30/04
25 } P = 10 cm H₂O
IAH = 6.5 elev
m. de uso: 7h30'
fuga = 0.0

Jua cláudia

P = 10 cm H₂O

IAH = 5.4

m. de uso 4h40 → másc. danif (troco o bojo)

Jua

Nome: LUIZ EUGENIO DAVI
Data de Nascimento: 14-5-1950
IMC: 24,39
Sexo: Masculino
Data do exame: 15-05-2023

Peso: 73 kg
Altura: 1,73 m
Médico: DR. PEDRO MACEDO
Medicamentos:
Histórico:

Laudo de Polissonografia

Exame realizado na noite de 15-05-2023, sendo feita avaliação simultânea de eletroencefalograma, eletrooculograma, eletromiograma (região submentoniana e músculo tibial anterior), posição corporal, ronco, fluxo aéreo nasal e oral, esforço respiratório torácico e abdominal, saturação arterial de oxigênio (SpO2) e eletrocardiograma. Os resultados encontram-se em anexo.

O tempo total de registro foi de 532,0 min. As latências de estágio N1 e sono de REM foram, respectivamente, 84,0 e 82,0 minutos. O tempo total de sono foi de 382,5 min, eficiência de 71,9% (normal > 85%) e as porcentagens das fases de sono em relação ao tempo total de sono foram: estágio N1: 3,0%; estágio N2: 56,5%; estágio N3: 17,0%; sono REM: 23,5%. O índice de despertares foi de 8,0/hora (normal < 10/h).

O índice de apneia/hipopneia total foi de 16,0/hora, sendo 2 obstrutivas, 0 mistas e 0 centrais e 99 hipopnéias. A SpO2 média foi de 91% e a mínima de 83%, permanecendo 5,4% do tempo de registro com a saturação abaixo de 90%. A frequência cardíaca no estágio REM oscilou entre 56 - 79 bpm e NREM de 56 - 80 bpm.

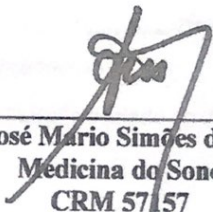
CONCLUSÃO: Os dados do registro polissonográfico, associados aos do Questionário de Sono e escala de Epworth (2), favorecem as seguintes hipóteses diagnósticas:

1. Polissonografia demonstrando eficiência do sono reduzida;
2. porcentagem do sono REM normal e porcentagem do estágio N2 do sono NREM aumentada;
3. índice de apnéia + hipopnéia (IAH) de 16,0/hora; ✓
4. houve dessaturação da oxihemoglobina (min. SaO2=83%);
5. latência para o sono aumentada e latência para o sono REM diminuída;
6. número de despertares breves normal;
7. presença de movimentos periódicos de membros inferiores (3,6/hora);
8. registro de ronco durante o sono.

Exame evidenciando apneia obstrutiva do sono de grau moderado.

IAH: 05-15 /hora leve.
IAH: 15-30 /hora moderada.
IAH: > 30 /hora acentuada.

Nota: O diagnóstico depende da correlação conjunta com outros fatores.


Dr. José Mario Simões da Costa
Medicina do Sono
CRM 57.57